

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent Information - Patient's Copy Drainage of a Pseudocyst

معلومات الإقرار – نسخة المريض
الكيس البنكرياسي تصريف سوائل شبه

1. What is the drainage of a pseudocyst?

The procedure will involve the drainage of a cyst in the area of the pancreas (a gland behind the stomach).

2. My anaesthetic

This procedure will require an anaesthetic.

See **About Your Anaesthetic information sheet** for information about the anaesthetic and the risks involved. If you have any concerns, discuss these with your doctor.

If you have not been given an information sheet, please ask for one.

3. What are the risks of this specific procedure?

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following:

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Increased risk in obese people of wound infection, chest infection, heart and lung complications, and thrombosis.
- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.
- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and

1. ما هو تصريف سوائل شبه الكيس البنكرياس ؟

يتم في هذا الإجراء إفراغ وتصريف محتويات شبه كيس في منطقة البنكرياس (غدة خلف المعدة).

2. التخدير الذي أتلقيه

سوف يتطلب هذا الإجراء الخضوع للتخدير .
اقرأ تعليمات التخدير المتعلقة بالإجراء الطبي المقرر لك للمزيد من المعلومات عن نوع التخدير والمخاطر المترتبة. إن كان لديك أي مخاوف أو تساؤلات قم بمناقشتها مع طبيبك المعالج.
إذا لم تقدم لك ورقة التعليمات ، نرجو عدم التردد في طلبها.

3. ما هي المخاطر المتعلقة بهذا الإجراء بالتحديد ؟

لهذا الإجراء مخاطر ومضاعفات وتشمل ، ولكنها غير مقتصرة على :

مخاطر عامة:

- قد يحدث التهاب ، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى
- قد يحدث نزيف مما قد يتطلب إعادة مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً إذا كنت ممن يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار دايابيردامول (بيرسانتن أو اساسانتن)
- قد يحدث انسداد للشعبات الهوائية الصغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالتهاب في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.
- عند أصحاب الأوزان الزائدة ، تزداد مخاطر الإصابة بالتهاب الجرح والصدر. مضاعفات في القلب والرئة ، وجلطات الأوعية الدموية
- قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.

- Death as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

- Especially in a male there may be difficulty passing urine and a tube may need to be inserted into the bladder. Until the bladder can empty normally.
- Deep bleeding in the abdominal cavity which may need fluid replacement or further surgery.
- The join which allows drainage may break down and bowel contents may leak into the abdominal cavity. This may need further surgery.
- Damage of the bowel may occur which may cause leakage of bowel fluid. This may need further surgery.
- Infections such as pus collections can occur in the abdominal cavity. This may need surgical drainage.
- The bowel movement may be paralysed or blocked after surgery and this may cause building up of fluid in the bowel with bloating of the abdomen and vomiting. Further treatment may be necessary for this.
- A weakness can occur in the wound with complete or incomplete, bursting of the wound in the short term, or a hernia in the long term. This may need further surgery.
- In some people healing of the wound may be abnormal and the wound can be thickened and the wound may be painful.
- Adhesions (bands of scar tissue) may form and cause bowel obstruction. This can be a short term or a long-term complication and may need further surgery.
- The cyst may recur.
- Increased risk in smokers of wound and chest infections, heart and lung complications and thrombosis.

- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مم يسبب ألم وتورم في الساق ، وفي حالات نادرة قد ينفصل جزء من التجلط ليصل إلى الرئة.
- الوفاة محتملة كنتيجة لهذا الإجراء.

مخاطر محددة متعلقة بهذا الإجراء:

- عند الذكور بصورة خاصة ، قد تكون هناك صعوبة في إدرار البول بعد الجراحة ، مما قد يتطلب وضع أنبوب (قسطرة بولية) في المثانة إلى أن تعود المثانة للإفراغ الطبيعي للبول.
- نزيف عميق في التجويف البطني قد يستدعي إعطاء سوائل لتعويض الدم المفقود أو جراحة أخرى.
- نقطة الوصل التي تتيح تصريف السوائل قد تتمزق مما قد يسبب تسرب محتويات الأمعاء للتجويف البطني. قد يتطلب ذلك جراحة أخرى.
- قد يحدث ضرر للأمعاء مما قد يسبب تسرباً لسوائل الأمعاء. قد يتطلب ذلك جراحة أخرى.
- الإصابة بالتهاب سائل البطن كتجمعات للصدى في التجويف البطني مما قد يتطلب تفريغ الصديد جراحياً .
- قد تصاب حركة الأمعاء بالانسداد أو بطء في الحركة بعد العملية مما يسبب تراكم السوائل في الأمعاء وانتفاخ للبطن وتقيؤ. قد يتطلب الأمر علاج آخر.
- ضعف قد يعتري الجرح ويؤدي على المدى القريب إلى تمزقه بشكل جزئي أو كامل ، وعلى المدى البعيد قد يتسبب ذلك في نشوء فتق. قد يتطلب ذلك جراحة أخرى.
- عند بعض المرضى ، يحدث التئام الجرح بشكل غير طبيعي. قد تزداد سماكة الجرح وقد يكون مؤلماً.
- قد تحدث التصاقات (أحزمة من الأنسجة المتندبة) وتسبب انسداداً للأمعاء. قد يحدث ذلك على المدى القريب أو البعيد وقد يحتاج حلاً جراحياً.
- قد يعود الكيس للظهور.
- عند المدخنين تزداد عدوى الجرح والصدر ومضاعفات القلب والرئة والتخثرات الدموية.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Notes to talk to my doctor about:

أُمُور أُنَاقِشُ حَولَها مَعَ طَبيبِي:
